Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Seberi

Av. General Flores da Cunha, 1467 - Bairro: Centro - CEP: 98380000 - Fone: (55)3029-9993 - Email: frseberivjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000780-42.2024.8.21.0133/RS

AUTOR: MARLENE ELIZA ALLES SCHMIDT

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

MARILENE ELIZA ALLES SCHMIDT, já qualificada, ajuizou **ação para fornecimento de medicamento com pedido de tutela de urgência** em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, também qualificado, alegando, que no ano de 2016 foi diagnosticada com CÂNCER DE MAMA EC IV (CID C50), HER2 positivo duas cruzes (+2), com fish negativo, e desde lá já fez vários tratamentos medicamentosos, na esperança de superar a patologia, sendo que atualmente apresentou metástases hepáticas disseminadas. Ressaltou que não dispõe de condição financeira para adquirir o fármaco e manter o tratamento. Prossegue narrando que o médico lhe prescreveu o medicamento **TRASTUZUMABE DERUXTECANA 100MG**, nome comercial "Enhertu". Disse que o réu tem obrigação de fornecer o fármaco postulado e colacionou jurisprudências. Requereu, em sede de tutela antecipada, o imediato fornecimento do medicamento de que necessita. Postulou, ao final, pela procedência da ação, confirmando a liminar. Vindicou a AJG. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

A inicial foi recebida e deferido o benefício da AJG e a tutela antecipada postulada (evento 4, DESPADEC1).

Citado o IPÊ-SAÚDE aportou contestação alegando que o medicamento postulado não está previsto no Protocolo Oncológico adotado para o tratamento da enfermidade apresentada. Teceu considerações acerca do sistema de saúde dos servidores públicos e sobre a manutenção de tal sistema. Referiu que o autor pretende um tratamento diferenciado que não será estendido aos demais segurados, o que fere o princípio da isonomia. Postulou pela improcedência da demanda. Acostou documento (evento 23, CONT1).

Houve réplica (evento 26, RÉPLICA1).

As partes foram intimadas sobre o interesse na produção de provas (evento 28) e alegaram não pretenderem referida dilação.

Por fim, o Ministério Público manifestu-se pela prodecência da demanda (evento 43, PROMOÇÃO1).

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

Cuida-se de ação na qual a parte autora objetiva o fornecimento pelo réu dos medicamentos TRASTUZUMABE DERUXTECANA 100MG.

Não há preliminares a serem analisadas e, no mérito, procede o pedido do autor.

Consigno que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar as poucas condições financeiras da parte autora em despender, mensalmente, da quantia necessária para compra dos medicamentos de que necessita no importe de R$ 1.385.500,00 (um milhão trezentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais) por ano de tratamento.

Outrossim, restam suficientemente comprovadas a existência da patologia e necessidade dos fármacos, bem como a urgência do uso da medicação pleiteada.

O laudo médico anexado no evento 1, LAUDO11 elenca a grave enfermidade do autor, diagnosticado com Neoplasia (CÂNCER DE MAMA EC IV (CID C50), HER2 positivo duas cruzes (+2), com fish negativo).

O Dr. Edilson Walter, CRM 28118, Oncologista Clínico, que assiste a autora, atestou que *"A paciente, 62 anos, apresenta diagnóstico de CÂNCER DE MAMA EC IV (CID C50), HER2 positivo duas cruzes (+2), com fish negativo. Apresenta metástases hepáticas disseminadas. Realizou tratamentos prévios com esquemas contendo antrciclina (AC) e taxanos em primeira linha de quimioterapia, tendo progredido a essas linas de tratamento. Ainda, realizou tratamento com inibidor de ciclina (ribociclibe) associado a bloqueio hormonal. Apresenta, no momento progressão tumoral com envolvimento metastático para fígado. A recomendação do uso de trastuzumabe deruxtecana (T-DXd) em em pacientes com tumores HER-2 baixo se baseia no estudo de fase III DESTINY Breast04. Foram incluídos pacientes com doença avançada e HER-2 baixo que haviam recebido uma ou duas linhas anteriores de QT. A randomização ocorreu de forma 2:1 para trastuzumabe deruxtecana versus QT à escolha do médico (opções: capecitabina, eribulina, gencitabina, paclitaxel ou nab-paclitaxel). O desfecho primário foi SLP na coorte RH positiva. Foram randomizadas 557 pacientes, sendo 494 (88,7%) com diagnóstico de doença RH positiva e 63 (11,3%) com diagnóstico de doença RH negativa (tumor TN HER-2 baixo). Na coorte RH positiva, a SLP mediana foi de 10,1 meses no grupo trastuzumabe deruxtecana e 5,4 meses no grupo de QT à escolha do médico (HR=0,51; p<0,001), e a SG foi de 23,9 e 17,5 meses, respectivamente (HR=0,64; p=0,003). Esse estudo consolida trastuzumabe deruxtecana como opção para pacientes com doença avançada definidas como HER-2 baixo e já*

submetidas previamente à QT em contexto de doença avançada [N Engl J Med 387:9, 2022]. O estudo foi atualizado na ESMO em 2023 e, com seguimento mediano de 32 meses, o DESTINY-Breast04 confirma melhora clinicamente sustentada, favorecendo T-DXd em detrimento à QT, independentemente do status de RH [Ann Oncol 34:abstr 376O, 2023]. Tendo em vista os benefícios apresentado nos estudos, a paciente deve iniciar o mais breve possível com TRASTUZUMABE DERUXETECANA 5,4 mg/kg EV, a cada 21 dias até toxidade ou progressão de doença. Este medicamento não deve ser substituído não possui similares. A paciente deve iniciar o medicamento com brevidade devido risco de progressão de doença e até mesmo risco de óbito".

Não pode ser afastada a credibilidade da prescrição efetuada pelo profissional que acompanha o tratamento da demandante, por possuir melhor condição de avaliar o seu estado de saúde e a prescrição recomendada.

Demonstrada, portanto, a necessidade e o cabimento do remédio postulado para o tratamento da grave doença que acomete a autora.

Quanto ao fornecimento, ressalto que o pedido da inicial não se alicerça na responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, disposta no art. 196 da Constituição Federal, mas na responsabilidade do Plano de Saúde, assim necessário observar as normativas que regulamentam o plano.

Consigno que, em 06 de abril de 2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, revogando, portanto, a Lei Complementar nº 12.134/04.

Desta feita, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu após a entrada em vigor da LC 15.145/2018, esta é a legislação aplicável ao caso.

Tal legislação dispõe sobre o IPE-Saúde e refere que o plano de saúde integra atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, *in verbis*:

> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema **IPE** Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, **bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários,** na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*

O parágrafo primeiro do artigo acima refere que os tratamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do IPERGS restam excluídos da cobertura do plano de saúde e o parágrafo segundo exige a aprovação do Órgão Gestor para inclusão de novos procedimentos, *in verbis*:

> *§ 1º **Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde** os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, **que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.***
>
> *§ 2º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do **IPE** Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial*

Todavia, em que pesem as disposições da nova lei, entendo que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado.

Ressalto que, as Recomendações Técnicas em Oncologia do próprio Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul não possuem a pretensão de ser completas ou definitivas e não apresentam caráter excludente, prevendo a possibilidade de exame de casos excepcionais, bem como a não intervenção na autonomia do médico assistente, assim entendo que descabe negar acesso do segurado a tratamento médico.

Cabe destacar, ainda, que a Resolução nº 21/1979, que regulamenta a assistência Médico-Hospitalar do IPERGS, assim dispõe:

> *Artº 2º - O plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes coibirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento.*
>
> *§ Primeiro – O Plano será restrito aos princípios da Medicina Curativa sendo, no entanto, admissível em casos especiais a instituição de procedimentos preventivos.*
>
> *§ Segundo – O Plano será fundamental baseado nos seguintes princípios:*
>
> *a) co-participação financeira do usuário.*
>
> *b) livre escolha dentre os profissionais ou entidades credenciadas.*
>
> *Artº 8º - Incluem-se no Plano de Assistência Médica, em consonância com as respectivas normas, as seguintes especialidades:*
>
> *Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geral, Ginecologia, Hematologia e Hemoterapia, Imunologia (Alergia), Medicina Nuclear, Nefrologia, Obstetrícia, Oftalmologia, **Oncologia,** Otorrinolaringologia, Patologia Clínica e Cirurgia, Pediatria, Plástica reparadora, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Tisiopneomologia, Torácica, Traumatologia e Urologia.*
>
> *(...)*
>
> *Artº 9º - A assistência médico-hospitalar abrangerá os seguintes serviços:*
>
> *1 – Emergências*
>
> *2 – Consultas Médicas*
>
> *3 – Serviços Complementares*

4 – Tratamento Ambulatorial

5 – Tratamento Hospitalar

Oportuno mencionar que a patologia que acomete a demandante – qual seja, neoplasia de mama encontra-se arrolada na Recomendação Técnica[1].

Em que pese o §1º do art. 4º da Lei Complementar n. 15.145/18, disponha que estão excluídos da cobertura os tratamentos que não estejam previstos nas tabelas do próprio instituto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é cristalino quanto à impossibilidade de o plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado.

Nesse sentido, destaco precedentes da Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. É abusiva a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. [...]. (AgInt no AREsp 1353634/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019)."

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais e contratuais. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018)."

É neste mesmo compasso que converge a jurisprudência do Tribunal de Justiça Gaúcho:

"APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. ECA. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UTIPEDIÁTRICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE OSÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. ***A responsabilidade pelo atendimento à saúde (no caso, transferência do paciente para hospital com UTI Pediátrica) é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração Pública.*** *2. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado. 3. Não há falar em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração. [...]. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA, NOS DEMAIS PONTOS, EM REEXAME NECESSÁRIO.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70081082984, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 16-05-2019)" grifei*

"REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPE-SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. METÁSTASE ÓSSEA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. ***TRASTUZUMABE*** *COM ENTANSINA (TDM1).* ***O segurado do IPE-SAÚDE tem direito ao recebimento de medicamento indispensável ao tratamento de sua grave moléstia, uma vez que a especialidade oncologia está coberta pelo plano de saúde para o qual contribui mensalmente. A alegada falta de contemplação, pelo protocolo do IPE-SAÚDE, do medicamento indicado não há de prevalecer quando prescrito por profissional especializado, credenciado pela Autarquia, que o teve como sendo o adequado e necessário para o tratamento da moléstia que acomete a parte****, NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA, com metástase óssea. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.(Remessa Necessária Cível, Nº 70085426260, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 27-10-2021)" grifei*

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. DEVER DE FORNECIMENTO PELO IPE-SAÚDE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELO IPERGS AO FADEP. DESCABIMENTO. 1. Caso em que a parte autora requer o fornecimento do medicamento Ibrutinibe, pois é segurada do IPE-Saúde e portadora de ***Linfocítica Crônica*** *(Leucemia). 2.* ***O IPERGS tem o dever de fornecer o tratamento postulado, não excluído do Plano de Saúde, e devidamente indicado por médico competente ao paciente. A ausência de previsão de medicamento em listas do réu não impede a determinação de fornecimento do tratamento necessário à saúde da parte apelada.*** *Inteligência das Leis nº 7.672/82, LC nº 12.134/2004, art. 196 da CF, e 241 da CE. Precedentes jurisprudenciais. 3. Comprovada a necessidade do tratamento médico prescrito pelo médico da requerente e a impossibilidade de aquisição deste, deve ser mantida a sentença que condenou o réu ao fornecimento da medicação. 4. Afastada a condenação do IPERGS ao pagamento de honorários em favor do FADEP uma vez que há confusão entre credor e devedor. Representativo de controvérsia repetitiva julgado pelo STJ e Precedentes Jurisprudenciais da Corte. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082864596, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 17-12-2019)" grifei*

Desta feita, entendo que o plano de saúde deve fornecer o tratamento de oncologia postulado, pois comprovada a enfermidade que acomete a autora e a necessidade da medicação.

Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARILENE ELIZA ALLES SCHMIDT, já qualificado, para CONDENAR o IPÊ-SAÚDE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPERGS ao fornecimento da medicação necessitada pelo autor, qual seja: <u>TRASTUZUMABE DERUXTECANA 100MG</u>, na dosagem indicada na inicial, enquanto durar o tratamento, confirmendo a tutela provisória de urgência de evento 4, DESPADEC1**.**

Determino que o autor apresente, a cada seis meses, laudo médico que demonstre a necessidade de se manter o fornecimento do medicamento.

Confirmo a decisão antecipatória da tutela, evento 04.

Condeno o IPERGS no pagamento de honorários advocatícios às procuradoras do autor, que, na forma do art. 85, §8º, do CPC, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

O réu é isento do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei nº 14.634/2014), não foram antecipadas custas pela parte autora nem houve despesas com Oficial de Justiça para reembolso.

Publicação e intimação automáticas.

Interposta a Apelação pela parte autora/requerida, intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo de 15 dias.

Com a juntada das contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **DAVI DE SOUSA LOPES, Juiz de Direito**, em 05/05/2025, às 18:07:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10081751486v3** e o código CRC **99f775e7**.

---

1. Disponível em: http://ipesaude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/22153315-rt-oncologia-20jan2020.pdf ↩